
title: Inflammatory metastasis is a metastatic tumor associated with fever, skin changes, soft tissue infl

지방종양의 염증성 전이

염증성 전이는 발열, 피부 변화, 부드러운 조직의 염증 및 실험실 이상을 동반하는 전이성 종양으로, 이는 기저에 있는 악성 종양을 가리키는 염증을 암시합니다. 본 연구에서는 69세 남성 환자에게서 관찰된 염증성 전이성 갑상선 종양을 보고합니다. 환자는 갑상선의 골수염과 유사한 임상 소견을 보였으며, 가슴 CT 검사에서 갑상선의 부위에 공기포가 퍼져 있는 것을 관찰할 수 있었습니다. 최종 진단은 갑상선의 기원 불명의 미분화된 전이성 암으로 확인되었습니다.

주요 키워드

- Sternum (갑상선)
- Bone Metastases (골 전이)
- Gas Gangrene (가스성 괴사)
- Carcinoma, Squamous (평상상피암)
- Multidetector Computed Tomography (다중검출기 컴퓨터 단층촬영)

서론

앞쪽 가슴 벽의 통증과 부종이 염증성 증상을 동반할 경우, 감염이나 관절염과 같은 염증 과정과 관련이 있을 수 있습니다 (1). 때로는 암과 같은 기저의 병리 과정이 감염으로 오해될 수 있으며, 이는 환자와 의료진 모두에게 치명적인 결과를 초래할 수 있습니다. 본 연구에서는 처음에는 가슴 근육의 가스성 괴사와 갑상선의 골수염으로 진단되었으나, 최종적으로 갑상선의 기원 불명의 전이성 암으로 진단된 고령 남성 환자의 사례를 보고합니다.

사례 보고

69세 남성이 발열과 가슴 앞 벽의 통증으로 입원하여 평가를 받았습니다. 그는 3개월 동안 가슴 앞 벽의 통증으로 여러 정형외과 클리닉을 방문했지만, 증상이 호전되지 않고 악화되었습니다. 입원 당시 체온은 39.8°C로 측정되었습니다. 통증은 가슴 앞 벽에 집중되어 있었으며, 특히 갑상선 주변에서 심했습니다. 가슴 앞 벽의 부드러운 조직은 부어오르고, 피부는 약간 발적되어 있었으며, 국소적으로 열감이 느껴졌습니다. 체격 검사 시, 균열 소리와 심한 통증이 동반되었습니다. 나머지 신체 검사에서 10년 전 발생한 뇌졸중으로 인한 왼쪽 반신 마비가 확인되었으며, 당뇨병의 병력은 없었습니다.

전혈구 검사 결과 혈색소 수치는 13.0 g/dL, 백혈구 수치는 21,900/mm³ (중립구 88%, 림프구 4.4%)였으며, 혈소판 수치는 240,000/mm³로 나타났습니다. 적혈구 침강 반응(ESR)은 1시간 후 121 mm로 측정되었고, C-반응 단백질(CRP)은 30 mg/L로 검출되었습니다 (정상 범위 < 0.7).